UE A1 · SEMESTRE 1 · TD 3 DU 23 OCTOBRE 2026

THÉORIE DE GESTION DES SYMPTÔMES

Fiche de révision écrite

Support officiel du TD et notes de cours

Pourquoi cette fiche ?

Comprendre comment Émilie vit ses migraines, analyser les facteurs qui influencent leur gestion, puis relier la théorie de gestion des symptômes au raisonnement infirmier.

Objectifs de la séance

- Comprendre une expérience de symptômes singulière.
- Identifier les facteurs internes et externes.
- Analyser les stratégies et leurs résultats.
- Comparer Henderson, TGS et trifocal.

Lecture à deux niveaux

Essentiel : définitions, dimensions et distinctions à mémoriser.

Pour comprendre : mécanismes, nuances et interactions.

En pratique : le cas d'Émilie, les choix de soins et la réévaluation.

Une démarche : 5 temps pour analyser une situation

1 · Recueillir	Écouter le récit et distinguer les faits des hypothèses.
2 · Comprendre	Relier personne, santé et environnement.
3 · Explorer	Perception, évaluation, vécu et cluster de symptômes.
4 · Co-construire	Choisir avec la personne des stratégies réalisables.
5 · Vérifier	Mesurer les effets, réévaluer et ajuster.

Sommaire rapide — six chapitres

01 · Comprendre la théorie des symptômes
02 · Analyser la situation d'Émilie
03 · Accompagner et évaluer les soins
04 · Trois regards infirmiers
05 · Préparer les évaluations
06 · Définitions et mots-clés

Réflexe de TD

La bonne question n'est pas seulement : « Quelle douleur ? » mais aussi : « Comment est-elle vécue, gérée et réévaluée dans la vie réelle ? »

01 Comprendre la théorie des symptômes

1.1 Objectifs et repères du TD

Ce TD du domaine A sollicite le raisonnement clinique infirmier : recueillir les éléments pertinents, comprendre la situation d'une personne et définir des interventions adaptées dans une démarche éthique, déontologique et co-construite. Il s'inscrit dans les compétences relatives au diagnostic infirmier et à la définition des interventions.

Le support propose une situation d'application centrée sur Émilie, puis relie la TGS au modèle des 14 besoins fondamentaux et au modèle clinique trifocal. Le CM de Stéphanie Pierre est rappelé : les trois cadres n'ont pas le même degré d'abstraction ni le même usage.

Priorité explicitement annoncée dans l'échange oral

L'évaluation universitaire a été évoquée comme probablement composée de QCM, éventuellement fondés sur des situations. Comprendre les facteurs influençant les symptômes et le ressenti, puis appliquer le raisonnement, importe davantage que réciter des intitulés. Aucune question exacte de partiel n'a été annoncée.

1.2 Une expérience qui dépasse la douleur

Le TD s'ouvre par une question : « Une migraine, est-ce seulement un mal de tête ? » Une même intensité de douleur, par exemple 7/10, peut correspondre à des expériences différentes. L'âge, l'histoire de la personne, les émotions, les connaissances, le sommeil, le stress, les contraintes professionnelles ou familiales, les ressources et l'environnement modulent ce vécu.

La démarche infirmière ne s'arrête donc pas à nommer « migraine » ni à enregistrer un chiffre. Elle cherche à comprendre la manifestation, son évolution, les autres symptômes, les répercussions sur la vie de la personne et ce qu'elle fait déjà pour y répondre.

À retenir

Même score de douleur ne signifie ni même expérience ni même réponse. La question utile est : « Comment cette personne perçoit-elle, évalue-t-elle et vit-elle ses symptômes ? »

1.3 Les trois dimensions de la TGS

La théorie de gestion des symptômes (TGS) est présentée comme une théorie intermédiaire. Entre un modèle conceptuel très général et l'observation d'une situation clinique, elle permet de comprendre un phénomène infirmier précis : l'expérience des symptômes et les moyens de les gérer.

Dimension de la TGS	Questions et éléments à explorer
Expérience du symptôme	Que perçoit la personne ? Comment évalue-t-elle ce qu'elle ressent ? Quel sens, quelle émotion et quel vécu y associe-t-elle ?
Stratégies de gestion	Que fait-elle pour prévenir, réduire, contrôler ou mieux supporter les symptômes ? Ces actions sont-elles réalisables ?
Résultats de la gestion	Les symptômes et leur retentissement changent-ils ? L'autogestion et la qualité de vie s'améliorent-elles ?

Ces trois dimensions s'influencent mutuellement. L'expérience influe sur les stratégies choisies ; les stratégies produisent des résultats ; les résultats conduisent à poursuivre, adapter ou réexaminer la démarche. Les facteurs personnels et environnementaux restent en interaction avec ce processus.

Lecture textuelle du schéma TGS (support p. 21)

Facteurs contextuels ↔ expérience des symptômes ↔ stratégies de gestion ↔ résultats ; les groupes de symptômes peuvent aussi s'influencer. Le schéma illustre un système dynamique, et non une suite rigide d'étapes isolées.

1.4 Personne, santé, environnement et soins

Les quatre piliers du métaparadigme infirmier sont : la personne, la santé / maladie, l'environnement et les soins infirmiers. Dans le cas d'Émilie, le TD commence par les trois premiers pour comprendre le contexte avant de proposer des actions de soins.

Pilier	Données dans la situation d'Émilie
Personne	22 ans ; étudiante en droit ; vit seule ; migraines anciennes ; expériences, représentations, émotions et stratégies déjà apprises.
Santé / maladie	Migraines depuis l'adolescence, habituellement 1 à 2 crises par mois ; douleur pulsatile d'un côté du crâne, 7–8/10 ; nausées et gêne à la lumière et au bruit ; fréquence récente en hausse.
Environnement	Études, examens, travail en magasin, logement, écrans, rythme d'activité, horaires, repas, famille éloignée et ressources à rechercher.
Soins infirmiers	Recueil de données, écoute, observation structurée, recherche des facteurs associés, accompagnement et réévaluation.

Facteurs internes et externes

Internes : exemples	Externes : exemples
Stress ressenti, fatigue, émotions, connaissances, représentations et expérience des crises.	Examens, horaires de cours et de travail, environnement de travail, temps d'écran, organisation des repas.
Réactions de la personne et manière de reconnaître les premiers signes.	Possibilité de se reposer, situation de logement, entourage et soutien disponibles à explorer.

Un facteur n'est pas toujours classable dans une seule case. La personne et son environnement sont en interaction permanente ; un classement utile à l'analyse ne doit pas devenir rigide. Il faut distinguer les données explicitement présentes du cas, les hypothèses raisonnables et les informations encore inconnues.

Note pédagogique de l'intervenante

Repérer la pertinence clinique d'un élément et sa relation aux autres facteurs est plus important que choisir à tout prix une unique catégorie « interne » ou « externe ».

1.5 Perception, évaluation et vécu

L'expérience des symptômes comprend trois lectures complémentaires. Le TD propose de répondre à : « Que ressent-elle ? Comment évalue-t-elle ce ressenti ? Comment le vit-elle ? »

Dimension	Émilie	Question infirmière
Perception	Petite douleur initiale sur un côté de la tête, puis douleur pulsatile, difficulté avec lumière et bruit, parfois nausées.	« Quels signes reconnaissez-vous au début de la crise ? »
Évaluation	Intensité habituelle 7 à 8/10, augmentation progressive, comparaison aux crises précédentes, conséquences sur ses activités.	« Comment la douleur évolue-t-elle ? Quelle fréquence ? Quelle gêne ? »
Vécu / réponse	Anxiété liée au retard pris dans les études ; elle cherche d'abord à terminer son travail, puis à s'arrêter.	« Qu'est-ce qui vous inquiète ? Que faites-vous dès les premiers signes ? »

Les catégories servent de repères, mais certaines données peuvent éclairer plusieurs dimensions. L'intensité numérique n'est qu'une partie de l'évaluation : le sens attribué, les ressources et le retentissement sont indispensables.

À retenir

Perception = manifestation ressentie ; évaluation = importance, caractéristiques, évolution et retentissement ; vécu = significations, émotions et réactions.

1.6 Reconnaître un groupe de symptômes

Un cluster est un ensemble de symptômes qui apparaissent ensemble, peuvent s'influencer et produire un retentissement commun. L'expérience d'Émilie associe à la douleur : nausées, gêne à la lumière, gêne au bruit, fatigue, anxiété et difficultés de concentration.

Explorer le cluster permet de ne pas laisser dans l'ombre des effets majeurs : difficulté à travailler, repos interrompu, inquiétude, retard dans les études. On ne peut pas évaluer correctement le retentissement global en n'interrogeant que le score de douleur.

Application clinique

Un « cluster de symptômes » n'est ni une complication obligatoire ni un diagnostic médical en soi. C'est une manière d'identifier des manifestations associées et leur effet sur la personne.

02 Analyser la situation d'Émilie

2.1 Comprendre les données du cas clinique

Partie 1 — Situation initiale

Émilie, 22 ans, vit seule à Paris. Elle étudie le droit et travaille quelques heures dans un magasin de surgelés pour subvenir à ses besoins. Elle rapporte des migraines depuis l'adolescence, auparavant une à deux fois par mois. Les crises entraînent généralement une douleur pulsatile unilatérale, parfois des nausées, une intolérance à la lumière et au bruit ; elles sont cotées 7 à 8/10. Elle doit souvent s'allonger au calme et dans le noir.

Partie 2 — Évolution et facteurs

Depuis un mois, elle a eu cinq crises. Elles semblent plus fréquentes pendant les examens ; elle veille tard, saute parfois le déjeuner et travaille longtemps devant un écran. L'exercice du TD invite à rechercher les facteurs internes et externes et leurs interactions, sans conclure qu'un seul facteur prouve la cause des migraines.

Partie 3 — Déroulement et expérience

Émilie reconnaît une petite douleur initiale, sait qu'elle risque d'augmenter, puis décrit une douleur pulsatile importante et des symptômes associés. Elle craint de perdre une journée de travail universitaire, ce qui majore son inquiétude. Elle continue néanmoins souvent son activité avant d'interrompre ses tâches.

Partie 4 — Habitudes de gestion

Lors des crises, elle arrête l'ordinateur, s'allonge dans le noir, évite le bruit, boit de l'eau, essaie de dormir et utilise son traitement de crise prescrit. Elle sait ce qui la soulage, mais ses stratégies ne suffisent plus toujours car elle agit tardivement.

Partie 5 — Consultation et suivi

L'infirmière explore le récit complet d'une crise, son contexte et ses conséquences, puis propose un carnet de suivi. Le suivi permet de repérer des régularités : moins de six heures de sommeil, repas sautés ou longue activité sur écran sans pause. Une association observée ne prouve pas, seule, la causalité.

> **Fil rouge du raisonnement**
>
> Recueillir les faits → explorer l'expérience → relier facteurs et symptômes → comprendre ce qui fonctionne ou non → construire avec Émilie une stratégie réaliste → mesurer et ajuster.

2.2 Stratégies d'autogestion et leurs limites

Avant la consultation, Émilie met déjà en œuvre des stratégies de gestion. Elles ont un intérêt réel : repos, obscurité, réduction du bruit, hydratation et recours à une prescription connue. Le rôle infirmier n'est pas de nier ces compétences mais d'évaluer leur efficacité, leur précocité et leurs limites.

Le fait d'utiliser elle-même un traitement prescrit ne signifie pas automatiquement qu'elle pratique l'automédication. La distinction dépend de l'existence d'une prescription et de ses modalités. Toute décision de modification de dose ou d'indication doit respecter le cadre de prescription.

Le problème décrit dans le TD est une gestion devenue insuffisante au regard de la fréquence des crises et de leur retentissement. La poursuite des révisions malgré les premiers signes est un comportement à explorer sans jugement, en tenant compte de ses contraintes universitaires.

03 Accompagner et évaluer les soins

3.1 Écouter, évaluer et accompagner

L'infirmière ne commence pas par imposer une liste de conseils. Elle invite Émilie à raconter le déroulement d'une crise, du premier signe à sa disparition. Elle explore la fréquence, l'intensité, la durée, les signes associés, les moments de survenue, le sommeil, l'alimentation, le stress, le travail sur écran, les stratégies et leur efficacité ressentie.

Étape	Action infirmière et intérêt
Explorer	Écoute de l'expérience, des représentations, de l'inquiétude et des priorités de la personne.
Objectiver	Recueil systématique, suivi des épisodes et appréciation de l'évolution et du retentissement.
Relier	Mettre en rapport symptômes, conditions de vie, habitudes et stratégies, sans inventer de causalité.
Accompagner	Faire émerger les actions réalisables, préciser les résultats souhaités et le besoin d'aide.
Réévaluer	Mesurer l'évolution et ajuster les stratégies avec Émilie.

Une augmentation de la fréquence et de la gêne invite à apprécier la situation clinique dans son ensemble et à envisager l'orientation adaptée si elle est nécessaire. Le TD ne donne pas de protocole médical ni de seuil d'urgence à inventer.

Note de cours

La valeur ajoutée infirmière est la structuration de l'observation, la recherche des facteurs associés, la mise en relation des données, l'accompagnement et la réévaluation.

3.2 Co-construire des stratégies réalistes

Quand Émilie entend plusieurs conseils, elle répond qu'elle ne pourra pas tout changer en même temps. L'infirmière lui demande quel changement lui paraît accessible dès cette semaine. Émilie choisit de ne plus sauter le déjeuner et de faire une pause toutes les deux heures devant son ordinateur.

Le support emploie le terme « adhérence ». Les ressources antérieures parlaient aussi d'« adhésion » : l'idée partagée est de rechercher un projet que la personne comprend, accepte et peut mettre en œuvre. Il ne s'agit pas d'obtenir une obéissance à un plan imposé.

Le choix d'une stratégie dépend donc autant de son intérêt que de sa faisabilité concrète. Le professionnel reformule, hiérarchise, négocie et adapte ; des ajustements ultérieurs et parfois des retours en arrière font partie d'une prise en soin réaliste.

Exemple de co-construction

Plutôt que « Vous devez changer tout votre mode de vie », demander : « Parmi les changements évoqués, lequel vous semble le plus facile cette semaine ? » Le résultat devient un engagement possible, à vérifier ensemble.

3.3 Observer les résultats et réévaluer

Le TD insiste sur des résultats réalistes et mesurables. Dans une situation chronique, viser automatiquement la disparition totale d'un symptôme n'est pas toujours pertinent. On peut chercher à réduire la fréquence ou l'intensité, contrôler les manifestations, prévenir certains épisodes, limiter leur retentissement et améliorer la qualité de vie.

Objectif choisi avec Émilie	Critères d'évaluation possibles
Ne plus sauter le déjeuner pendant les journées de révision.	Consigner les journées où le repas a été pris et mettre en relation avec le carnet de crises.
Faire une pause toutes les deux heures de travail sur écran.	Repérer la possibilité de réaliser les pauses, le rythme des crises et la gêne ressentie.
Limiter les perturbations des études et de la vie quotidienne.	Suivre la fréquence des crises, l'intensité rapportée et le retentissement fonctionnel.

L'efficacité se juge sur des données et sur ce que la personne considère comme utile. Selon les résultats obtenus, on conserve, on modifie ou on négocie une autre stratégie. La réévaluation fait partie de la démarche, elle ne constitue pas une étape facultative.

04 Trois regards infirmiers complémentaires

4.1 Henderson, TGS et modèle trifocal

La dernière partie du support met en relation trois cadres complémentaires, du plus abstrait au plus concret. Il ne s'agit pas de les appliquer mécaniquement, mais de choisir un regard qui éclaire la question clinique posée.

Approche	Question-clé	Lecture d'Émilie
14 besoins de Virginia Henderson	Quels besoins perturbés, quelle autonomie et quel besoin d'aide ?	Boire / manger, dormir, se reposer, activités et capacités de gestion.
TGS (théorie intermédiaire)	Comment les symptômes sont-ils perçus, évalués, vécus et gérés ?	Migraines, facteurs contextuels, stratégies personnelles et résultats.
Modèle clinique trifocal	Quels signes du problème médical, quels risques et quelles réactions humaines ?	Manifestations de migraine, risques à anticiper sans les inventer, inquiétude et retentissement observés.

Trifocal : distinguer trois axes sans les confondre

- Axe 1 : problème de santé et manifestations (signes et symptômes observés ou rapportés).
- Axe 2 : risques ou complications potentiels à apprécier ; un risque n'est pas une réaction déjà constatée.
- Axe 3 : réactions humaines réelles, telles que l'inquiétude ou les conséquences sur l'activité lorsqu'elles sont exprimées.

Le support annonce une étude approfondie du modèle trifocal au semestre 2. Ici, le niveau attendu est le rapprochement des trois lectures. Le choix d'un cadre dépend de la personne et des questions de soin ; les trois peuvent être mobilisés dans une même situation.

Synthèse comparative

Henderson aide à analyser les besoins et l'autonomie ; la TGS aide à comprendre les symptômes et l'autogestion ; le trifocal aide à organiser le jugement clinique autour du problème de santé, des risques et des réactions.

05 Préparer les évaluations

5.1 Ce que l'enseignante demande de maîtriser

Ce que l'enseignante a explicitement souligné

• Savoir comprendre et appliquer la TGS, particulièrement dans une situation chronique.

• Savoir repérer facteurs, expérience du symptôme, stratégies, objectifs et retentissement.

• Ne pas classer rigidement une donnée qui relève de plusieurs dimensions.

• Préparer l'analyse d'une situation, notamment sous forme de QCM contextualisé ; travailler aussi les 14 besoins pour le stage.

• Accompagner la négociation et l'adhérence du patient plutôt que décider unilatéralement.

Ce que les exercices permettent de déduire

• Expliquer pourquoi cinq crises dans le mois représentent un changement par rapport aux une à deux crises habituelles.

• Repérer le cluster et les conséquences de l'intensité seule comme indicateur.

• Différencier fait, hypothèse, réaction humaine réelle et risque potentiel.

• Proposer un critère de résultat et une réévaluation cohérents avec le plan choisi.

Mini-cas de révision

Émilie a cinq crises ce mois-ci. Une réponse argumentée consiste d'abord à explorer ce changement et son vécu, sans attribuer immédiatement toutes les crises au stress, puis à construire avec elle une intervention réaliste et à en suivre les effets.

5.2 Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion à éviter	Correction argumentée
« Migraine = douleur seule »	Le TD décrit aussi nausées, intolérance à la lumière et au bruit, fatigue, anxiété et concentration difficile.
« Deux douleurs à 7/10 = même expérience »	Le ressenti dépend du contexte, des ressources, de l'histoire personnelle et du retentissement.

Confusion à éviter	Correction argumentée
« Un score suffit pour évaluer le symptôme »	Rechercher aussi évolution, durée, symptômes associés, comportements et conséquences.
« Interne et externe sont toujours exclusifs »	La personne et l'environnement interagissent ; la catégorie n'est qu'un outil de lecture.
« Cluster = complication certaine »	C'est un groupe de symptômes pouvant interagir.
« Le patient doit suivre exactement les conseils »	Adhérence et co-construction supposent compréhension, accord et faisabilité.
« Gérer seule sa prescription = automédication »	Le fait de respecter une prescription connue ne signifie pas automatiquement automédication.
« Un risque est déjà présent »	Dans le trifocal, le potentiel doit rester distinct des réactions effectivement constatées.
« Le modèle trifocal remplace la TGS »	Les regards sont complémentaires et adaptés à la question posée.
« Un carnet prouve un facteur déclenchant unique »	Un suivi fait émerger des liens à discuter, sans preuve causale automatique.
« Fin de consultation = fin du suivi »	Résultats, adhérence et stratégies nécessitent réévaluation et ajustement.

5.3 Synthèse générale — L'essentiel du cours

La TGS est une théorie intermédiaire centrée sur l'expérience des symptômes, leurs stratégies de gestion et leurs résultats. Ces dimensions sont dynamiques et influencées par le contexte de la personne.

L'expérience du symptôme se comprend par perception, évaluation et vécu. Le cas d'Émilie réunit douleur, nausées, intolérance à la lumière et au bruit, fatigue, anxiété et difficultés de concentration ; le score de douleur ne suffit pas.

Émilie rapporte cinq migraines sur un mois, contre une à deux habituellement. L'enjeu est d'explorer cette évolution, la relation avec ses études, son sommeil, ses repas, les écrans, les stratégies existantes et leur efficacité, sans transformer une hypothèse en cause certaine.

L'infirmière écoute, structure le recueil, discute des stratégies accessibles, construit des objectifs mesurables avec la personne et réévalue les résultats. L'adhérence n'est pas une obéissance à des conseils imposés.

Henderson explore les besoins et l'autonomie ; la TGS étudie le vécu et l'autogestion ; le trifocal structure manifestations, risques potentiels et réactions humaines réelles. Ces lectures peuvent se compléter.

06 Définitions et mots-clés

Lexique de révision : les termes essentiels des ressources précédentes sont conservés et enrichis à partir du TD. Les définitions sont formulées pour être relues, copiées ou utilisées dans des entraînements oraux.

Symptôme	Manifestation ressentie ou rapportée par une personne ; son intensité seule ne résume pas son expérience.
Théorie de gestion des symptômes (TGS)	Théorie intermédiaire reliant expérience des symptômes, stratégies de gestion et résultats dans un contexte.
Théorie intermédiaire	Théorie ciblant un phénomène infirmier spécifique et utile à l'action clinique.
Métaparadigme infirmier	Quatre regards de la discipline : personne, santé / maladie, environnement et soins infirmiers.
Personne	Sujet du soin avec son parcours, ses représentations, émotions, priorités, capacités et ressources.
Santé / maladie	Situation de santé, manifestations, évolutions et répercussions identifiées dans le recueil.
Environnement	Conditions de vie, études, travail, horaires, entourage, contraintes et ressources disponibles.
Soins infirmiers	Écoute, observation structurée, évaluation, accompagnement, co-construction et réévaluation.
Facteurs contextuels	Éléments propres à la personne ou à son environnement qui influencent le vécu et la gestion.
Facteur interne	Élément personnel tel que stress ressenti, expérience antérieure, fatigue ou représentations.
Facteur externe	Élément du cadre de vie tel que contraintes universitaires, horaires, écrans ou disponibilité des repas.
Interaction	Influence réciproque entre personne, environnement, symptômes, stratégies et résultats.
Perception	Premiers signes que la personne ressent et reconnaît.
Évaluation du symptôme	Appréciation de l'intensité, de la fréquence, de l'évolution, de la durée et du retentissement.
Vécu / réponse au symptôme	Signification donnée à la manifestation, émotions et réactions qu'elle suscite.
Cluster de symptômes	Groupe de symptômes simultanés ou associés qui peuvent interagir et produire un retentissement commun.
Autogestion	Actions mises en place par la personne pour gérer ses symptômes dans son quotidien.

Auto-soins	Mesures autonomes de soin ou de confort ; elles peuvent inclure un traitement prescrit respecté.
Automédication	Prise d'un médicament de sa propre initiative ; ne pas confondre avec l'usage autonome d'une prescription.
Stratégie de gestion	Action visant à prévenir, réduire, contrôler ou limiter le retentissement d'un symptôme.
Résultat de la gestion	Effet mesurable de la stratégie sur les symptômes, la vie quotidienne et la qualité de vie.
Adhérence / adhésion	Participation à une démarche choisie et acceptable, comprise et réalisable dans la vie réelle.
Co-construction	Élaboration des objectifs et actions avec la personne, plutôt que leur imposition.
Négociation thérapeutique	Recherche avec la personne d'une stratégie acceptable, tenant compte de ses priorités et limites.
Objectif réaliste	But concret, atteignable et mesurable dans la situation actuelle.
Réévaluation	Nouvelle observation des symptômes, des résultats et de l'adéquation des stratégies.
Cahier / carnet de suivi	Outil de suivi des épisodes, contexte, manifestations, conséquences et stratégies, à interpréter avec prudence.
14 besoins fondamentaux	Modèle de Virginia Henderson qui aide à analyser les besoins perturbés et le niveau d'autonomie.
Modèle clinique trifocal	Outil structurant le raisonnement selon signes / problème de santé, risques et réactions humaines.
Risque potentiel	Situation possible à anticiper, distincte d'une réaction déjà présente.
Réaction humaine réelle	Réponse physique, émotionnelle ou sociale effectivement rapportée ou observée.
Raisonnement clinique	Mise en relation des données et connaissances utiles pour définir une intervention adaptée.
Jugement clinique	Interprétation argumentée d'une situation à partir des données disponibles.
Retentissement fonctionnel	Conséquences sur études, travail, sommeil, autonomie, relations et activités.
Échelle numérique (EN)	Cotation de la douleur rapportée par la personne : une information à relier au vécu et aux signes associés.
Photophobie	Difficulté à supporter la lumière, décrite dans la situation de migraine d'Émilie.
Pause de travail	Interruption planifiée de l'activité ; Émilie choisit une pause toutes les deux heures de travail sur écran.